

Если вы рассматриваете операцию по поводу пролапса тазовых органов, вам предстоит принять ряд решений вместе с хирургом. **Единственно «правильного» ответа, как правило, не существует — оптимальный план зависит от вашей анатомии, состояния здоровья и ваших приоритетов. Этот листок поможет подготовиться к осознанному разговору.**

Основные решения

- **Реконструкция или закрытие** — восстановить опору тазовых органов и сохранить влагалище открытым, или закрыть влагалище (кольпоклеизис), если вы не планируете влагалищный секс.
- **Доступ** — через влагалище или через живот (лапароскопически или роботически).
- **Матка** — удалить (гистерэктомия) или сохранить с помощью подвешивающей операции (гистеропексия).
- **Материал для опоры** — собственные ткани, биологический трансплантат или сетчатый имплант (например, при сакрокольпопексии).
- **Недержание мочи** — нужно ли одновременно выполнить операцию против подтекания мочи (см. ниже).

Скрытое недержание мочи

Большой пролапс иногда **маскирует** стрессовое недержание мочи (SUI), которое проявляется только после его устранения («скрытое» SUI). Ваш врач может проверить это и обсудить, стоит ли одновременно установить слинг или подождать.

ТЕРМИНЫ

Реконструктивная операция

Восстановление опоры с сохранением функции влагалища.

Облитерирующая операция

Закрытие влагалища (кольпоклеизис) — надёжно, но исключает половые контакты.

Гистеропексия

Подвешивающая операция с сохранением матки.

Пластика собственными тканями

Операция без трансплантата или импланта.

Скрытый SUI

Стрессовое недержание, проявляющееся после коррекции пролапса.

Рецидив

Возвращение пролапса со временем.

КАК ВЫБРАТЬ? Сопоставьте варианты с **вашими** приоритетами — надёжность, сроки восстановления, сохранение матки, сексуальная активность и отношение к сетчатым имплантам. Хирург порекомендует то, что подходит именно вашей анатомии; «лучший» вариант — тот, который отвечает вашим целям после открытого обсуждения.

Вопросы хирургу

- Какую **операцию (операции)** вы рекомендуете мне и почему?
- **Влагалищный или брюшной** доступ — каков период восстановления при каждом?
- Можно ли (и нужно ли) **сохранить матку**?
- Будут использованы **собственные ткани, трансплантат или сетка** — каковы риски?
- Нужна ли **операция против недержания мочи** сейчас или позже?
- Каков риск **рецидива** и что делать, если пролапс вернётся?

Полезно знать

- **Пессарий** — всегда доступная нехирургическая альтернатива, если вы хотите отложить или избежать операции.
- Нормализация веса, лечение запоров и кашля, а после менопаузы — вагинальный эстроген улучшают результаты операции.

Как подготовиться

- Пройдите все **предоперационные обследования** и принесите полный список принимаемых лекарств.
- Запланируйте **отказ от курения** и организуйте помощь дома.
- Помните общее правило восстановления: исключить тяжёлые нагрузки и секс на ~6 недель.

Сообщите врачу перед операцией, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете нарушения свёртываемости
- Имеете текущую инфекцию **мочевыводящих путей или влагалища**
- Отмечаете новую **боль в тазу, кровотечение или незаживающую рану** в области выпячивания

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Операция при пролапсе включает несколько решений — реконструкция или закрытие, доступ, сохранение матки, материал для опоры и лечение скрытого недержания.
2. Редко существует единственно верный ответ; лучший план соответствует вашей анатомии и приоритетам.
3. Задавайте ключевые вопросы и помните, что пессарий всегда остаётся нехирургической альтернативой.